

Silvia Torrisi

MONOFOBIA

CG 



Metamorfosi

x

Silvia Torrisi

Monofobia

Calamus CG

Edizione a cura di Calamus CG
Firenze, luglio 2025

Impaginazione realizzata con Adobe InDesign
Testo composto in Linux Libertine G Regular, corpo 11 pt

Pubblicazione a fini esclusivamente accademici e personali.

© 2025 Silvia Torrisi – Calamus CG

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.

*A chi c'è, c'è stato e ci sarà.
La paura è più leggera se condivisa.*



Introduzione

Almeno una volta nella vita la maggior parte di noi si è sentita sola. Chi durante le feste, chi perché l'unica persona single in un gruppo di sole coppie, chi perché non ha molti amici o non si sente capito. Spesso queste situazioni si risolvono nel momento in cui si trova un partner, un amico fidato o si crea la propria famiglia in cui sentirsi amati. Ancora più spesso questa sensazione di solitudine si affievolisce nel momento in cui impariamo ad amare noi stessi, ad accettarci e a non giudicarci. Questo saggio però non parla di solitudine, parla di una condizione non molto conosciuta caratterizzata da ansia e paura, che pervade la vita di chi la prova ed è nota con il nome di «monofobia». Questo testo ha lo scopo di illustrare, senza pretese scientifiche e con un tono adatto a chiunque, i tratti salienti di questa fobia. Partendo dalle sue origini andremo a conoscerne le cause e i modi per fronteggiarla, vedremo l'impatto che ha avuto su di essa il lockdown dovuto al Covid-19, il rapporto con gli attacchi di panico e la solitudine e i possibili aspetti positivi. Approfondiremo due prospettive moderne che mirano a rivoluzionare l'approccio al malessere: una nuova

branca della psicologia concentrata più sulla soluzione che sul problema e una tecnica di rilassamento che fa da ponte tra le tradizioni buddiste e le terapie occidentali.

Per facilitare la lettura di questo saggio sulla monofobia sono riportati numerosi esempi che non fanno riferimento a persone realmente esistite ma prendono spunto da situazioni reali.

Che cos'è la monofobia?

1.1 Definizione

Il termine «monofobia» è composto dalle parole «mono» e «fobia» (dal gr. *μovo-*, «unico, solo» e dal gr. *-φοβία*, «temere») e può essere tradotto come il «timore ossessivo della solitudine»¹. Si tratta di una condizione che può essere conosciuta anche con altri nomi («autofobia, isolofovia, ecofobia, eremofobia») e chi ne soffre teme il restare da soli, paura che anche se solo immaginata può provocare sentimenti di ansia e preoccupazione irrazionali e ingovernabili. Questo timore può riguardare la lontananza da una persona specifica, lo stare da soli a casa o in pubblico. La sola prospettiva di trascorrere del tempo in solitudine, anche in luoghi sicuri e familiari, può provocare una reazione di terrore che però non si basa su una minaccia reale. Non è insolito che una persona che soffre di monofobia si possa sentire sola anche se circondata da altre persone; il terrore è talmente elevato e persistente da compromettere diversi aspetti dell'esistenza di chi ne soffre, andando a incidere

sulla qualità della vita e delle relazioni. Non sempre però chi ne soffre ne è consapevole: i sentimenti di angoscia e paura vengono attribuiti ad altre cause e non ci si rende conto che la sorgente primaria è il timore di stare da soli.

Ma cosa si intende per «paura»? Non si tratta solamente di un'emozione negativa spesso ritenuta disfunzionale e inaccettabile ma è anche una delle cinque emozioni primarie (insieme a rabbia, felicità, tristezza e disgusto) e nasce con la funzione adattiva di risposta al pericolo, come allarme per fronteggiare una situazione minacciosa e quindi come garanzia della nostra sopravvivenza. Se non affrontata, però, la paura può generare un circolo vizioso di evitamento e amplificazione dello stato di ansia. Spesso utilizziamo strategie disfunzionali per ridurre la paura che, anziché appianarla, ce la fanno percepire con più frequenza e con maggiore intensità, arrivando a peggiorare la qualità della nostra vita. La paura è spesso accompagnata dall'ansia, definibile come uno stato psicofisico contraddistinto dalla presenza di agitazione, attivazione fisiologica e incertezza². Anche in questo caso si può parlare di risposta innata di allarme con la funzione di aumentare la nostra vigilanza e prepararci ad affrontare il pericolo. Se però l'ansia diviene persistente e incontrollabile può diventare patologica.

All'interno del DSM-5 (*Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*) non è presente una parte dedicata alla monofobia ma possiamo analizzarla facendo riferimento ai disturbi d'ansia. In questa categoria si trovano quei disturbi che presentano caratteristiche di paura e ansia eccessive come risposte emotive a una minaccia reale o percepita come

2 Cfr. H.S. Bracha, J.D. Maser, Anxiety and Posttraumatic Stress Disorder in the Context of Human Brain Evolution: A Role for Theory in DSM-V?, «Clinical Psychology: Science and Practice», 15 (1), 2001, pp. 91-97.

tale. Per passare dalla condizione di comportamento momentaneo a quella di disturbo è necessario che vengano rispettati alcuni criteri diagnostici come nel caso della fobia specifica, ovvero la paura diretta verso una determinata situazione, che per essere diagnosticata deve soddisfare i sette criteri elencati nel Dsm-5 tra cui: la paura eccessiva o irragionevole provocata dalla presenza o dall'attesa di una situazione specifica; la scarsa tolleranza alla situazione fobica vissuta con intensa ansia o disagio; l'interferenza significativa tra la situazione temuta e le normali abitudini della persona, il suo funzionamento lavorativo (o scolastico) e le relazioni sociali; l'assenza di altri disturbi mentali che giustifichino la presenza dell'ansia, degli attacchi di panico o dell'evitamento.

Le persone con disturbi d'ansia temono o evitano determinate situazioni perché sopravvalutano il pericolo e molto spesso rispondono fuggendo come teorizzato da Charles Darwin, ovvero con il famoso *Fight or Flight* (attacco o fuga), poi ampliato con l'aggiunta dei termini *Freeze* (congelamento) e *Fright* (paura)³. Le quattro F rappresentano reazioni evolutive a stress acuti o a situazioni che ai nostri occhi appaiono come pericolose. Nel caso della monofobia la prima risposta che mettiamo in atto quando si presenta la possibilità di rimanere da soli è il congelamento (*Freeze*), ovvero l'attivazione dello stato di allerta e ipervigilanza che ci blocca di fronte allo stimolo fobico. In seguito a questa prima risposta può sopraggiungere la paura (*Fright*), talmente elevata da produrre un'immobilità tonica che aumenta la nostra vulnerabilità. In seguito, dopo esserci paralizzati al pensiero di rimanere da soli, mettiamo in atto la fuga (*Flight*), cioè scappiamo da ciò che temiamo. In rife-

3 Cfr. R. Torta, Che cosa è l'ansia: basi biologiche e correlazioni cliniche, Editoriale Disease Management a cura della Società Italiana di Medicina Generale, Torino 2008.

rimento alla monofobia, si manifesta cercando compagnia o allontanandosi il più possibile dalla situazione temuta.

Quando si decide o si tenta di combattere la paura si passa al combattimento vero e proprio (Fight): questo tentativo può essere effettuato da soli o con l'aiuto di terapie *ad hoc* di cui parleremo più avanti.

La monofobia può essere anche definita come la paura irrazionale di passare del tempo senza la presenza di una persona fidate che da ora in avanti chiameremo «persona sicura». Ma come riconoscere se si soffre di monofobia? I sintomi si possono presentare in modi diversi e variare da persona a persona. Alla sola prospettiva di trascorrere momenti da soli si manifesta immediatamente uno stato ansioso che può essere esperito anche in situazioni di gruppo nelle quali la persona si sente estranea a ciò che le accade intorno. I sintomi più frequenti sono: impulso alla fuga; affaticamento della respirazione; paura di una minaccia imminente; senso di insicurezza; percezione di perdere i sensi; sensazione di ottundimento; paura di morire. A livello fisiologico si possono presentare sintomi simili a quelli provati durante un attacco di panico, tra i quali vertigini, iperventilazione e tremore.

Per parlare di monofobia non è necessario che siano presenti tutti i sintomi sopra elencati, le persone che ne soffrono possono esperirle tutte o solo alcune e possono variare nel tempo. Facciamo per esempio il caso di Elena, una ragazza di diciotto anni che soffre di monofobia da quando ne aveva otto. All'inizio è difficile stabilire se una persona durante l'infanzia soffra di una fobia specifica o stia semplicemente attraversando una normale tappa del suo sviluppo evolutivo, ma è possibile riconoscerlo attraverso alcuni campanelli di allarme. Elena non voleva mai uscire di casa se non accompagnata dalla sua sorellina Letizia (due anni più piccola di lei)

e lamentava malessere fisico quando questa era fuori casa. I suoi genitori attribuivano il malessere alla naturale fase di sviluppo caratterizzata dall'attaccamento tra fratelli e sorelle, ma quando le lamentele si sono amplificate e Letizia ha iniziato a essere più indipendente si sono resi conto che il malessere di Elena non era più giustificabile dall'età e hanno deciso di rivolgersi a uno psicologo. Crescendo, Elena non ha più manifestato dolore a livello fisico ma ha iniziato a essere soggetta a pensieri paralizzanti che non le permettevano di fare nulla senza la sorella. Ma perché si sviluppa la monofobia? Qual è la causa scatenante di questa condizione?

1.2 Perché si presenta?

Non esiste una causa elettiva legata all'insorgenza della monofobia. Come abbiamo visto sussistono diverse varianti della paura di rimanere da soli e ognuna di esse può essere ricondotta a una motivazione psicologica latente. Possiamo collegare questa particolare condizione alla famiglia dei disturbi d'ansia a cui faremo riferimento per l'individuazione delle possibili cause di insorgenza. Per esempio, la paura di essere da soli in pubblico (senza l'appoggio della persona sicura) può essere ricondotta alla fobia sociale o all'agorafobia. Un'altra possibile causa può risalire a vissuti abbandoni subiti durante l'infanzia che sfociano successivamente in sentimenti di inadeguatezza e scarsa autostima, presenti sia nelle situazioni sociali che in chi teme di rimanere in casa da solo. Questi vissuti possono essere ricondotti a un attaccamento insicuro durante l'infanzia, causa prevalente del disturbo d'ansia da separazione.

Quando parliamo di fobia sociale ci riferiamo alla «paura o ansia marcate relative a una o più situazioni sociali nelle quali l'individuo è esposto al possibile esame degli altri». Proviamo a pensare a una grande conferenza dove improvvisamente l'occhio di bue viene a indicare proprio noi, soli in mezzo a centinaia di sconosciuti. Ecco che arrivano le «4F»: Freeze, seguito da Fright con la possibilità di apparizione di Fight o di Flight. Proviamo a immaginare la complessità di sensazioni provate da chi soffre di monofobia: accelerazione della respirazione, sensazione di ottundimento, tremori, paura di svenire. Ma perché emergono queste sensazioni? Quando si inizia a soffrire di fobia sociale o di monofobia? L'esordio può essere ricondotto a esperienze umilianti o stressanti vissute durante l'infanzia, o avvenire in età adulta in seguito a cambiamenti della propria vita a livello intimo o sociale (cambio lavoro, trasferimenti, separazioni). I fattori di rischio che favoriscono l'insorgenza di tale condizione sono molteplici e possono essere: temperamentali (inibizione comportamentale o paura del giudizio altrui), ambientali (maltrattamenti o avversità infantili), genetici e fisiologici (ereditarietà). Non esiste una singola causa scatenante ma molto spesso si tratta di una commistione tra questi diversi fattori. Per quanto riguarda l'agorafobia si tratta di «paura o ansia marcate relative a due (o più) delle seguenti cinque situazioni: 1) utilizzo dei trasporti pubblici; 2) trovarsi in spazi aperti; 3) trovarsi in spazi chiusi; 4) stare in fila oppure tra la folla; 5) essere fuori casa da soli». Immaginiamo una persona che soffre di monofobia a un concerto all'aperto durante il quale si ritrova improvvisamente senza la sua persona sicura. Inizieranno a montare dentro di lei la paura di essere in un luogo aperto e affollato da sola, la sensazione di insicurezza seguita dall'ottundimento e la consapevolezza di non poter fare nulla.

A differenza di quei momenti in cui avvertiamo una paura presente ma governabile, le persone affette da monofobia, anche se consapevoli dell'irrazionalità della situazione, si trovano nell'impossibilità di reagire e di tollerare momenti di solitudine. È possibile notare come la monofobia sia legata a entrambi i disturbi d'ansia appena visti (fobia sociale e agorafobia) per quanto concerne il dover rimanere con altre persone, sia al chiuso che all'aperto, senza il supporto della persona sicura. Nel caso dell'agorafobia l'esordio è più tardivo rispetto alla fobia sociale, in quanto si sviluppa a partire dalla tarda adolescenza. Uno dei criteri diagnostici di questo disturbo implica la presenza dell'evitamento attivo, ovvero la riduzione o la totale eliminazione delle situazioni ritenute agorafobiche sia a livello comportamentale che cognitivo. Questo può comportare una compromissione marcata della qualità della vita così come avviene per chi soffre di monofobia.

Un altro disturbo d'ansia legato all'insorgenza della paura di stare da soli è il disturbo d'ansia da separazione. Per poter comprendere meglio questa condizione è d'obbligo fare un riferimento alla teoria dell'attaccamento di Bowlby. Secondo questo studioso l'attaccamento madre-bambino (poi riformulato in attaccamento *caregiver*-bambino), è il presupposto per lo sviluppo dei sistemi comportamentali legati alla paura, all'esplorazione e alla socializzazione. Bowlby identifica tre principali stili di attaccamento: sicuro, insicuro-ambivalente e insicuro-evitante, successivamente ampliati da Main e Solomon con l'aggiunta dello stile disorganizzato-disorientato.

L'importanza di uno stile di attaccamento sicuro instaurato durante la prima infanzia funge da fattore di protezione, in quanto permette al bambino di sperimentare un senso di sicurezza accompagnato dalla sensazione di essere meritevole

di amore, fiducioso nelle proprie capacità e incline a instaurare relazioni sociali positive. Quando questo non avviene è possibile imbattersi nel disturbo d'ansia da separazione caratterizzato da «paura o ansia eccessiva e inappropriata rispetto allo stadio di sviluppo che riguarda la separazione da coloro a cui l'individuo è attaccato [...]»⁴. Anche in questo caso si fa riferimento alla persona sicura. Se, per esempio, vedessimo un bambino di cinque anni piangere disperatamente e mettersi in posizione fetale perché ha perso di vista il suo papà, istintivamente andremmo da lui per consolarlo e rassicurarlo. Ma se invece di un bambino di cinque anni ci imbattessimo in un uomo di quarantacinque anni disperato e in posizione fetale perché è rimasto senza la sua persona sicura probabilmente non lo tratteremmo nello stesso modo ma proveremmo a farlo ragionare sul fatto che ormai è adulto e in grado di badare a se stesso. Questo però può risultare più complesso per una persona con monofobia che senza la persona sicura non si sente capace di andare avanti; anche stare a casa da soli può risultare una sfida pericolosa, caratterizzata da angoscia prolungata per le sensazioni di insicurezza e inadeguatezza provate.

Questa particolare condizione ha i suoi esordi durante l'infanzia e raramente in adolescenza. I bambini con questo disturbo non sono in grado di dormire o stare in camera da soli e ricercano sempre qualcuno a cui fare «da ombra», mentre da adulti si mostrano riluttanti a viaggiare da soli e riportano frequenti incubi e sintomi fisiologici come vertigini, sensazione di svenimento e accelerazione cardiaca. Gli adulti con disturbo d'ansia da separazione spesso non ricordano un esordio in età infantile ma ne ricordano i sintomi. È comune che chi soffre di questo disturbo possa manifestare paure correlate come la paura del buio, dei ladri, di

viaggiare o di stare lontani da casa e mostrare sensazioni di tristezza, apatia, difficoltà di concentrazione o ritiro sociale. La paura di stare a casa da soli può dipendere dal timore che qualcuno entri di nascosto e li derubi o gli faccia del male, ma anche dall'incapacità di gestire l'ignoto. Appaiono evidenti i punti di connessione con chi soffre di monofobia: riluttanza alla solitudine o, in assenza della persona sicura; sensazioni fisiologiche legate a una situazione ritenuta stressante; paura marcata di trovarsi in un luogo, chiuso o aperto, da soli o senza possibilità di fuga. Abbiamo visto che le cause che portano all'insorgenza della monofobia possono essere varie e presentarsi in momenti diversi della vita e sono strettamente legate a fattori di protezione (come un attaccamento sicuro durante l'infanzia) e a fattori di rischio (temperamento, eventi stressanti e corredo genetico).

1.3 Come possiamo affrontarla?

Chiunque sospetti di soffrire di monofobia dovrebbe rivolgersi al proprio medico per poter escludere eventuali cause fisiche e farsi indirizzare verso un professionista della salute psicologica. Attualmente sono disponibili diversi trattamenti per i disturbi d'ansia tra cui il più diffuso è la Tcc, Terapia cognitivo comportamentale, trattamento d'elezione per la cura dell'ansia e delle fobie. L'obiettivo della Tcc non è solamente la riduzione immediata del disagio, ma il cambiamento dei processi che lo generano⁵.

5 Cfr. S. Sassaroli, R. Lorenzini, G.M. Ruggiero, Psicoterapia cognitiva dell'ansia: rimuginio, controllo ed evitamento, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006.

I trattamenti cognitivo comportamentali per i disturbi d'ansia mirano a ridurre e successivamente eliminare del tutto le paure irrazionali e i comportamenti di evitamento. L'obiettivo finale è quello di aumentare il senso di sicurezza e auto-efficacia del paziente per aiutarlo a migliorare la qualità della vita. Questi trattamenti sono spesso portati avanti parallelamente allo svolgimento di pratiche corporee, di rilassamento e respirazione.

1.3.1 Terapia di esposizione

La Tcc si avvale di diverse tecniche tra cui la più conosciuta è la tecnica di esposizione con la quale il paziente si trova ad affrontare gradualmente le situazioni temute in ambienti protetti e con la supervisione di un terapeuta. L'esposizione può essere: in vivo (presentazione dello stimolo fobico reale), immaginata (con l'utilizzo della realtà aumentata) o enterocettiva (induzione delle sensazioni fisiche che il paziente associa alla situazione temuta). Negli anni si è assistito a un'evoluzione di questa tecnica che oggi non si basa più esclusivamente sul confronto ripetuto con stimoli paurosi ma sfrutta numerose modalità operative in grado di massimizzarne l'efficacia.

Per esempio, attraverso la desensibilizzazione si mettono in pratica tecniche di rilassamento per ridurre i livelli di ansia durante l'esposizione allo stimolo, basandosi sull'assunto che una persona non possa provare contemporaneamente ansia e rilassatezza.

Nonostante sia ritenuto uno degli approcci più efficaci nel trattamento dei disturbi d'ansia, un numero considerevole

di pazienti ha paura di provarlo o presenta ricadute dopo la terapia⁶. Ricerche recenti hanno individuato alcune strategie funzionali per massimizzare l'efficacia della terapia di esposizione. A livello comportamentale troviamo:

1. l'etichettatura delle emozioni, ovvero l'espressione a voce alta della paura provata durante l'esposizione;
2. la violazione delle aspettative, cioè la creazione volontaria di predizioni errate durante l'esposizione (per potenziare l'apprendimento inibitorio);
3. la separazione tra processi impliciti ed espliciti;
4. la variabilità dello stimolo per consolidare l'apprendimento inibitorio;
5. la riduzione delle attività dopo l'esposizione;
6. l'esposizione mattutina (per la maggior presenza di cortisolo che facilita la memoria di estinzione);
7. il consolidamento degli apprendimenti delle esposizioni precedenti.

A livello neuronale invece si può agire attraverso una stimolazione elettrica del cervello durante l'esposizione. In questo modo si potenziano i processi di estinzione della paura condizionata riducendone l'influenza. Sono utilizzate anche la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione del nervo vago che vanno ad agire rispettivamente sulla plasticità e l'eccitabilità cerebrale di fronte agli stimoli fobici e sulla modulazione dell'apprendimento inibitorio.

6 Cfr. M.G. Craske, K. Kircanski, M. Zelikowsky, J. Mystkowski, N. Chowdhury, A. Baker, Optimizing inhibitory learning during exposure therapy, «Behaviour Research and Therapy», 46, 1, 2008, pp. 5-27.

1.3.2 Interventi di psicoeducazione

Gli interventi di psicoeducazione di solito vengono proposti in gruppo per la prevenzione e la cura di diversi disturbi sia in età infantile che in età adulta. L'assunto di base è che più l'individuo è consapevole di quello che prova più sarà in grado di gestirlo e affrontarlo. Attraverso la raccolta di informazioni e la condivisione con altri con la medesima sintomatologia, la persona diventa più competente e di conseguenza più incline al miglioramento in un'ottica di *empowerment* individuale. Per quanto concerne i disturbi d'ansia i pazienti vengono edotti al riconoscimento della sintomatologia e dei meccanismi alla base delle manifestazioni ansiose; successivamente gli vengono proposte le strategie possibili per fronteggiarle e quelle disfunzionali da evitare per non accrescere il disturbo. Di solito il trattamento inizia con gli interventi di psicoeducazione per poi passare alle tecniche di esposizione e alla ristrutturazione cognitiva.

1.3.3 Ristrutturazione cognitiva

La ristrutturazione cognitiva è una tecnica che ha come obiettivo la modifica dei pensieri irrazionali o disfunzionali alla base delle manifestazioni della fobia⁷. I pensieri, da soliti, sono capaci di provocare conseguenze a livello emo-

⁷ Cfr. G. Caselli, C. Manfredi, G.M. Ruggiero, S. Sassaroli, La Terapia Cognitivo-Comportamentale dei Disturbi d'Ansia: una revisione degli studi di efficacia, «Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale», 22(1), 2016.

tivo (ansia e paura), fisico (accelerazione cardiaca, respiro affannoso e sudorazione) e comportamentale (evitamento). La terapia ha il compito di ristrutturare, attraverso il dialogo, i pensieri irrazionali del paziente che si trova a mettere in discussione le proprie credenze disfunzionali, comprendendo la differenza tra pensiero negativo e pensiero irrealistico. Proviamo a immaginare di essere a casa da soli nel nostro appartamento al sesto piano e di sentire dei rumori. Il pensiero negativo che si può immediatamente presentare è che qualcuno sia entrato, opzione che ci porta con cautela a controllare tutte le stanze per assicurarci che non sia così. Il pensiero da negativo equilibrato diventa irrazionale quando immaginiamo che qualcuno sia entrato da una finestra chiusa del sesto piano e si stia nascondendo pronto per ucciderci. La possibilità che questo accada è estremamente ridotta e il compito del terapeuta è quello di condurre il paziente alla consapevolezza, a livello cognitivo, di quello che potrebbe o non potrebbe succedere realmente in una determinata situazione.

1.3.4 Terapia metacognitiva

La terapia metacognitiva (Mct) è una recente forma di psicoterapia utilizzata per la cura dei disturbi d'ansia e della depressione. Il termine «metacognizione» riguarda il diventare consapevoli dei nostri pensieri e delle nostre strategie cognitive come la memorizzazione, la comprensione, il ragionamento e il *problem-solving*. Per esempio, quando leggiamo un testo e ci rendiamo conto che ci siamo distratti e ritorniamo alla riga precedente siamo di fronte a

un processo metacognitivo. All'interno dei disturbi d'ansia è comune fare esperienza del rimuginio, ovvero un pensiero negativo ripetuto e difficile da controllare che causa stati d'animo negativi e distorsione della percezione della realtà. La Mct mira a far sviluppare al paziente la capacità di riconoscere tali pensieri e reagirvi modificando credenze metacognitive disfunzionali per acquisire un maggior controllo sul rimuginio.

1.3.5 Schema Therapy

La Schema Therapy (St) è un recente modello di terapia utilizzato specialmente quando i pazienti non rispondono bene al trattamento con la Tcc. A differenza di quest'ultima, che si focalizza esclusivamente sul momento presente, la St esplora anche le esperienze pregresse del paziente per identificare e comprendere i bisogni emotivi insoddisfatti che portano poi alla creazione degli schemi disfunzionali. Questo approccio si avvale di tecniche focalizzate sulle emozioni, tecniche cognitive e comportamentali. Tra quelle focalizzate sulle emozioni troviamo un intervento chiamato «dialogo con le sedie» nel quale vengono utilizzate le sedie per rappresentare le diverse parti del paziente e favorire un dialogo tra di loro⁸.

8 Cfr. A. Arnt, G. Jacob, *Schema Therapy in azione: teoria e pratica*, Istituto di scienze cognitive editore, Sassari 2013, p. 23.

1.3.6 Tcc di terza generazione

Negli ultimi anni sono emersi alcuni limiti relativi alle terapie comportamentali di prima e seconda generazione che hanno portato numerosi clinici e ricercatori a formulare nuove ipotesi di trattamento. Tra le più note troviamo la Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), la Dialectical Behavior Therapy (DBT) e l'Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Queste nuove terapie, chiamate di terza generazione, si basano sulla pratica della *mindfulness* che consiste nel «porre attenzione in un modo particolare: intenzionalmente, nel momento presente e in modo non giudicante».

1.3.6 Terapia farmacologica

In alcuni casi, in associazione alla psicoterapia, è necessario procedere con un trattamento farmacologico prescritto dal medico. Tra i farmaci più utilizzati troviamo i beta-bloccanti (capaci di bloccare l'adrenalina rilasciata durante le situazioni che generano paura) e le benzodiazepine (che aiutano a ridurre l'ansia). Anche i farmaci serotoninergici possono risultare efficaci nella cura di specifiche fobie così come la somministrazione di ormoni che modulano la percezione della paura.

1.3.7 Tecniche di rilassamento

Le tecniche di rilassamento, di respirazione e di riduzione dello stress sono spesso utilizzate in sinergia ad altri approcci terapeutici. Questi trattamenti agiscono sulla respirazione, sul rilassamento muscolare e sulle pratiche corporee. L'obiettivo è quello di trovare un equilibrio psicofisico, tra corpo e psiche, al fine di garantire il benessere e la riduzione dello stress. Tra i vari approcci esistenti possiamo citare il rilassamento muscolare progressivo di Jacobson, che mira a ridurre la tensione muscolare che permane anche quando siamo a riposo⁹. La tecnica è molto semplice e si basa su esercizi di contrazione e rilascio di gruppi muscolari grazie ai quali si apprende il rilassamento progressivo. Gli esercizi proposti richiedono dai cinque ai venti minuti ed è quindi possibile svolgerli ogni giorno anche più volte al giorno e possono concentrarsi su una singola parte del corpo o su tutte. Questa tecnica può essere svolta anche senza la presenza di un terapeuta anche se è sempre consigliabile consultare un professionista che insegni a svolgerla nel modo corretto. Per iniziare è necessario sedersi o sdraiarsi in un posto tranquillo e provare a sgomberare la mente facendo dei respiri lenti e profondi per almeno un minuto. In seguito si passa alla zona del corpo maggiormente contratta e si procede contraendo i muscoli (per almeno cinque secondi) e poi rilassandoli (dai quindici ai venti secondi), con delle piccole variazioni a seconda della parte del corpo interessata. L'esercizio si ripete dalle due alle cinque volte fino al raggiungimento della distensione muscolare. Di seguito alcuni esempi per i vari distretti corporei:

9 Cfr. J. Wolpe, *Psychotherapy by reciprocal inhibition*. Conditional reflex: a Pavlovian journal of research & therapy, 3(4), 1968, pp. 234-240.

- volto. Corrugare la fronte, strizzare gli occhi e stringere le labbra. Poi rilassare;
- mandibola. Stringere i denti. Poi rilassare;
- spalle e collo. Sollevare le spalle all'altezza delle orecchie mantenendo la schiena dritta. Poi rilassare;
- mani e avambracci. Stringere la mano destra a pugno e piegare il braccio per due volte. Ripetere con il braccio sinistro e poi con entrambe le braccia;
- addome. Tirare in dentro l'ombelico. Poi rilassare;
- bacino e glutei. Stringere i glutei e il bacino. Poi rilassare;
- gambe. Contrarre i muscoli della gamba destra tenendo il piede a martello. Poi rilassare. Ripetere a sinistra;
- piedi. Spingere le dita dei piedi verso il corpo. Poi rilassare.

Un'altra tecnica molto utilizzata nella gestione dell'ansia è il training autogeno di Schultz che consiste in esercizi di rilassamento autoindotti suddivisi in inferiori e superiori. Gli esercizi inferiori conducono l'attenzione alle sensazioni corporee mentre quelli superiori alle rappresentazioni mentali. All'interno di questa pratica si svolgono sei diversi esercizi di rilassamento: pesantezza (per rilassare i muscoli); calore (per dilatare i vasi sanguigni periferici); cuore (per la funzionalità cardiaca); respiro (per l'apparato respiratorio); plesso solare (per l'addome) e fronte fresca (che agisce a livello cerebrale). Un altro approccio è quello incentrato sulla respirazione, che si avvale di diverse tecniche come il respiro consapevole, la respirazione a narici alternate o la respirazione addominale profonda. Infine chi soffre di disturbi d'ansia può

affidarsi alle pratiche corporee come la danza movimento terapia, lo yoga o la bioenergetica che si concentrano sul ristabilire l'equilibrio tra psiche e corpo dando la possibilità a quest'ultimo di esprimersi attraverso il movimento.



La monofobia oggi

Come abbiamo visto finora non esiste un'unica forma di monofobia con le stesse cause e manifestazioni ma varia da persona a persona e da situazione a situazione; allo stesso modo cambia anche il modo di reagire e di conseguenza la qualità della loro vita. Per esempio, chi teme il restare da solo in pubblico potrebbe attuare delle strategie di fronteggiamento per far sì che questo non impatti completamente sul resto della sua vita: fa smart-working, invita gli amici a casa per cena e si fa portare la spesa a domicilio. Questi sono modi per reagire al problema che, anche se limitano alcuni campi della vita che con una buona terapia potrebbero migliorare, sono forme di fronteggiamento valide per convivere con la propria fobia. In un altro esempio, invece, possiamo vedere come la vita di una persona con monofobia possa deteriorarsi velocemente se non viene messa in atto nessuna strategia: non va più a lavoro, mangia solo cibo da asporto ed elimina del tutto la vita sociale. In questo caso la qualità della vita peggiora sensibilmente e l'incidenza del malessere aumenta in modo esponenziale non solo a livello sociale ed emotivo ma anche economico, fisico e di

salute in generale. Bisogna però stare attenti a non confondere la monofobia con la solitudine, condizione simile solo all'apparenza.

2.1 Monofobia e solitudine

Perché quando si parla di monofobia si pensa subito alla solitudine? Per quanto a uno sguardo superficiale possano sembrare costrutti simili, si tratta di due condizioni molto diverse tra loro. Con la parola «solitudine» si fa riferimento alla sensazione di sentirsi da soli in situazioni passeggiare o durature, sensazione a volte temuta e a volte ricercata che non include il terrore incontrollabile provato da chi soffre di monofobia, che esperisce emozioni quali paura e angoscia ben lontane dalla tristezza e dallo sconforto provate da chi si sente solo. Una persona che prova solitudine è colei che, passando un sabato pomeriggio da sola in casa, nutre pensieri di abbandono e afflizione dovuti al sentirsi esclusi da un mondo che sembra saper vivere meglio di lei. Questi sentimenti di solitudine riguardano sia la sfera emotiva che quella sociale, indissolubilmente legate tra loro. Peplau e Perlman hanno definito la solitudine «come la discrepanza esistente tra le relazioni sociali desiderate e quelle reali, condizione che provoca un'esperienza emotivamente spiacevole influenzata dalla nostra personale percezione della situazione». In molte occasioni, infatti, la solitudine non è legata a un'esperienza reale di isolamento ma alla percezione che noi abbiamo della stessa. Spesso chi afferma di sentirsi solo viene deriso o non preso sul serio perché sempre circondato da persone e apparentemente ben inte-

grato e questo non fa altro che implementare il sentimento di esclusione e solitudine provato. Facciamo un esempio. Giovanni ha ventitré anni e di professione fa il modello; trascorre ogni giorno in compagnia degli amici e posta sui social immagini di luoghi esotici e feste alla moda; è invidiato dalla gran parte dei suoi follower e dei suoi amici ma quando torna a casa la sera si sente invadere dalla tristezza e si sente solo; ha provato a parlarne con la sua ragazza che però minimizza quello che sente, facendogli notare che ha una vita fantastica e non ha motivo di essere triste. In queste situazioni è importante individuare la causa scatenante della tristezza: Giovanni può anche avere all'apparenza la vita perfetta che tutti sognerebbero ma se non appena rimane solo si sente invadere dallo sconforto e sente che nessuno lo capisce significa che qualche valore per lui importante è stato violato o che le scelte che fa non sono in linea con i suoi ideali. Giovanni in questo caso ha due possibilità: riempire il più possibile le sue giornate per ridurre al massimo il tempo in cui rimane da solo o prendersi un po' di tempo per ascoltarsi e capire cosa potrebbe fare per aumentare il suo benessere. Ma come si fa a capire se ci si sente soli o se si ha paura di stare da soli? Se si teme la solitudine o si tratta di una forma di fobia più marcata? Per un occhio esterno non è facile comprendere la natura di questa condizione ma per chi esperisce queste sensazioni la risposta è più chiara: se quando siamo da soli siamo tristi e pensiamo a come vorremmo che fosse la nostra vita sentimentale e sociale, crucciandoci del fatto che nessuno ci capisce, stiamo verosimilmente di fronte a un episodio di solitudine; se invece il solo pensiero di rimanere da soli provoca in noi angoscia e paura incontrollabili, con la necessità di avere qualcuno vicino, ci troviamo di fronte a una forma di monofobia. A volte il non voler stare da soli può essere ricondotto

al timore di ascoltarsi, di essere quindi costretti a cedere a pensieri che vorremmo non avere: ricordi passati, rimpianti, rimorsi, perdite o anche scelte che non vorremmo prendere ma che bussano insistentemente alla nostra porta. Nel caso sopracitato abbiamo descritto una possibile manifestazione della solitudine; andiamo ora a vedere due esempi di cosa prova chi soffre di monofobia. Francesca è una ricercatrice di ventiquattro anni, la più giovane all'interno del gruppo di ricercatori di psicologia dell'università della sua città; è fidanzata con Caterina da quando aveva sedici anni e da sempre è in buoni rapporti con la sua famiglia. I suoi amici la descrivono come una persona solare, estroversa, disponibile e che non si tira mai indietro, anche se non fa niente senza la presenza della sua ragazza. Questo a volte infastidisce gli amici che credono che Caterina sia troppo invadente e non lasci a Francesca il tempo per se stessa; quello che non sanno è che è proprio Francesca a volere che Caterina sia sempre presente in qualità di sua persona sicura. Ciò che gli amici scambiano per estrema disponibilità è l'incapacità di Francesca di rimanere da sola, ciò la porta a vedere ogni invito come ancora di salvezza dalla sua fobia e a vedere Caterina come appoggio su cui poter sempre contare. Diversa è la storia di Greta, una donna di cinquantacinque anni che lavora come cassiera al supermercato, che per tutta la vita ha fatto i conti con attacchi di panico ogni qual volta si trovava da sola in casa. La prima volta che le è successo aveva quattordici anni e i suoi genitori erano appena usciti per andare al lavoro. Improvvisamente si è sentita invadere da brividi di freddo e la frequenza cardiaca ha iniziato ad aumentare; non sapendo spiegare il motivo del suo malessere ha chiamato subito i suoi genitori e non appena sono rientrati a casa ogni sintomo è sembrato svanire. Questa stessa situazione si è poi presentata quotidianamente e per contra-

starla Greta ha iniziato a modellare la sua vita sugli impegni dei genitori al punto da non iscriversi all'università e iniziare a lavorare nello stesso supermercato dove lavorava il papà. Greta continua tutt'oggi a vivere con i suoi genitori e non ha mai avuto una storia sentimentale duratura perché i suoi partner non riescono a reggere il costante bisogno di non essere lasciata sola.

Ma è possibile imparare a stare da soli? o si è destinati a essere infelici e a fare scelte limitanti per il resto della propria vita? Imparare a convivere con la monofobia è possibile e il primo passo è parlarne apertamente e chiedere aiuto; per iniziare è importante acquisire competenze sociali ed emotive che ci permettano di aumentare la nostra consapevolezza e instaurare relazioni significative soddisfacenti, in modo da sanare il divario tra relazioni desiderate e relazioni reali, creando in questo modo una rete di supporto accogliente che ci permetta di essere noi stessi senza sforzo e senza maschere. Per poter acquisire queste competenze una possibilità viene offerta dai gruppi di psicoeducazione che propongono incontri sull'emotività, le relazioni e le *life-skills*, progettati non solo per chi soffre di monofobia ma anche per chi vive insieme a queste persone in modo da creare un sistema di supporto a 360°. Le *life-skills*, infatti, sono un mix di competenze cognitive, emotive e relazionali che ci permettono di vivere meglio e che riguardano la capacità di: risolvere problemi, prendere decisioni, gestire lo stress, comunicare in modo efficace, avere consapevolezza digitale, provare empatia e sviluppare pensiero critico e creativo¹⁰. Infine, per distinguere tra solitudine e monofobia può essere utile analizzare i sintomi; oltre a tristezza, an-

10 Cfr. A. Pellai, B. Tamborini, Destinazione Vita. Life Skills: il bagaglio essenziale per affrontare il viaggio più importante, Mondadori, Milano 2021, p. 14.

goscia e paura si possono manifestare comportamenti che ricordano un attacco di panico, un disturbo d'ansia spesso presente in comorbidità con la manifestazione di fobie.

2.2 Monofobia e attacchi di panico

Molte persone riferiscono di soffrire di attacchi di panico, ripetuti o occasionali. Ma cosa sono esattamente e come si fa a riconoscerli?

Un attacco di panico è un episodio improvviso e inaspettato caratterizzato da intensa paura e da una serie di sintomi cognitivi e somatici come paura di morire, sudorazione, vertigini, nausea, palpitazioni e brividi; può presentarsi come episodio singolo o evolvere in un vero e proprio disturbo di panico. La durata media di questi attacchi è di circa dieci-venti minuti anche se possono durare molto meno e in alcuni casi anche di più e spesso si manifestano in seguito, o durante, un periodo di forte stress e stanchezza. Le persone che soffrono di monofobia possono sperimentare molti dei sintomi presenti durante un attacco di panico come:

- paura di perdere il controllo o di impazzire;
- capogiri e vertigini;
- dolori al petto o addominali;
- respirazione accelerata;
- sensazione di soffocamento;
- iperventilazione;
- palpitazioni e tachicardia;
- sudorazione intensa;
- brividi o vampate di calore;
- nausea;

- senso di debolezza;
- tremori;
- parestesie (intorpidimento o formicolio degli arti).

Per parlare di attacco di panico non è necessario che siano presenti tutti i sintomi sopra elencati; alcune persone, per esempio, sperimentano solo uno o due sintomi e sempre gli stessi mentre altri ne presentano di più e possono variare da episodio a episodio. Anche la frequenza e l'intensità non sono costanti: alcuni attacchi possono verificarsi regolarmente ogni settimana, a volte più intensamente a volte meno, altri possono essere più discontinui e non presentarsi anche per diversi mesi o addirittura anni, con intensità variabile. Gabriele, per esempio, ne ha avuti solo due in tutta la sua vita: uno molto forte durante il secondo anno di università che lo ha portato, durante una lezione in cui era seduto al centro della fila, a pensare che sarebbe svenuto o che gli stesse per venire un attacco di cuore; il secondo quando si è reso conto che stava facendo un lavoro che non lo soddisfaceva ma sul quale aveva investito anni e denaro e che non sapeva come lasciare (in quel caso sono sopraggiunti sudori freddi e senso di nausea). Anche se si è trattato di due casi isolati nell'arco di dieci anni, Gabriele vive con la costante paura che questi possano ripresentarsi e soppesa ogni scelta della sua vita in modo da evitare di ritrovarsi in simili situazioni. Durante questi momenti si sviluppano pensieri automatici e incontrollabili che prendono il sopravvento sulla nostra lucidità e fanno apparire le situazioni come pericolose e impossibili da affrontare. È comune, in questi casi, che si ipotizzi la presenza di una malattia pericolosa per la vita e non ancora diagnosticata (com'è successo a Gabriele durante la lezione). Le persone che soffrono di questi attacchi tendono a rispondervi con l'evitamento, evitano cioè tutte quelle situazioni che

potrebbero generarli: riducono le uscite, diminuiscono le attività (come incontrare gli amici o prendere mezzi pubblici) e non partecipano alle riunioni di lavoro.

Questi comportamenti portano a una drastica riduzione della qualità della vita che può essere evitata chiedendo aiuto al proprio medico o rivolgendosi a un professionista con il quale scegliere insieme il trattamento più adeguato tra quelli elencati nel primo capitolo. Rientrando nell'ambito della monofobia, può essere utile citare la storia di Daniele, un uomo di sessantacinque anni che da quando è morta la moglie non riesce più a fare nulla da solo: per andare al supermercato chiama sempre la sorella (la sua persona sicura) e non esce più di casa se non per andare dal medico (quando non riesce a ottenere una visita a domicilio). La prima volta che Daniele è uscito da solo, dopo il funerale della moglie, ha avuto la sensazione che il mondo gli girasse intorno e ha iniziato a percepire palpitazioni e senso di stordimento. Alcuni passanti lo hanno aiutato e quando è tornato a casa ha deciso che non sarebbe più uscito da solo. In questo caso possiamo vedere come la monofobia sia la risultante di un attacco di panico singolo che ha avuto il potere di influenzare la vita di Daniele al punto da portarlo a rimanere chiuso in casa per la maggior parte del tempo. In altre situazioni accade invece il contrario: gli attacchi di panico si presentano dopo molto tempo rispetto alla comparsa della monofobia; non è detto che questo accada, esiste la monofobia senza attacchi di panico come esistono questi ultimi senza la prima, ma è possibile che alcuni dei sintomi che li caratterizzano si presentino quando una persona rimane da sola o in assenza della sua persona sicura. Proviamo ora a immaginare di essere costretti a stare da soli e non poter fare nulla per cambiare la situazione come è successo nel 2020 durante il *lockdown*. Come hanno

fatto le persone con monofobia a contrastare l'isolamento e resistere fino alla riapertura?

2.3 Monofobia e lockdown

Nel 2020 tutto il mondo si è fermato. Di paese in paese è stata imposta la chiusura totale, il cosiddetto «lockdown», per contenere il contagio da Covid-19. La pandemia, sviluppata in seguito alla diffusione del Coronavirus (Sars-CoV-2), ha messo in ginocchio per prima la Cina e subito dopo è arrivata in Italia, costringendoci all'isolamento. Persone che già manifestavano il timore di stare da sole si sono ritrovate faccia a faccia con la loro paura più grande e da marzo 2020 sono state costrette a rimanere a casa senza la possibilità di vedere la loro persona sicura o di stare in compagnia di qualcuno; altri invece, che non avevano mai sofferto di questa condizione, si sono ritrovati a esperire sentimenti di timore e angoscia in situazioni che fino a quel momento non avevano mai rappresentato un problema per loro.

In un periodo storico caratterizzato dalla paura dell'estraneo e del potenziale contagio, nelle persone affette da monofobia si è amplificato il timore di rimanere da sole, accompagnato da un eguale timore di stare in compagnia di qualcuno. Questi pensieri in contrasto tra loro, noti con il nome di «dissonanza cognitiva», hanno contribuito a incrementare il disagio di chi ha dovuto fare i conti non solo con gli effetti della pandemia ma anche con quelli derivanti dalla monofobia. Proviamo a pensare all'impossibilità di incontrare un nostro caro per timore di poter esser contagiati o di essere noi a contagiare. Aggiungiamo a questo il

bisogno incontrollabile di avere qualcuno vicino per poter sopravvivere e potremo avere un quadro dell'esperienza provata dalle persone con monofobia durante il lockdown. Le conseguenze psicofisiche e sociali della pandemia sono state tali da aver portato a un'implementazione delle forme di supporto psicologico anche gratuito per far fronte ai nuovi disagi sviluppatisi in seguito all'isolamento e al diffondersi del contagio. Durante l'isolamento le persone costrette a stare da sole ventiquattro ore su ventiquattro a contatto con la loro fobia si sono ritrovate inermi di fronte a qualcosa di sconosciuto e incontrollabile, impotenti contro un nemico infido e subdolo che le convinceva di non poter fare nulla per stare meglio.

Questo è il caso di Isabella, donna di ottantaquattro anni che non ha potuto vedere i suoi familiari per un anno e che è andata incontro a un generale deterioramento fisico e cognitivo a causa del prolungato stato di isolamento e della sua fobia di stare da sola. Isabella, non avendo familiarità con la moderna tecnologia, per un anno ha intrattenuto relazioni superficiali solo tramite telefonate o con i corrieri che settimanalmente le andavano a portare la spesa; per lei questo periodo è stato ostile e insopportabile ma per fortuna non è stato così per tutti. Pensiamo alle persone che temono le situazioni sociali di gruppo o i contesti esterni senza la propria persona sicura. In quei casi l'isolamento dovuto alla pandemia non è stato visto e vissuto come qualcosa di paralizzante o come fonte di nuovo disagio bensì come culla per le proprie paure, una giustificazione ai propri bisogni. Questo gruppo di persone ha fatto del lockdown una risorsa, si è sentito per la prima volta parte di una società che non lo giudicava perché non voleva uscire ma che restava a casa con lui. In molti casi la scoperta di questa nuova consapevolezza ha portato all'emergere di nuovi sentimenti di

accettazione sia da parte di chi manifesta la monofobia sia da parte di chi la vede dall'esterno, che per la prima volta ha compreso la portata di tale condizione.

Portiamo adesso l'esempio di Sonia, una ragazza transessuale che nel 2018, dopo anni di terapie psicologiche, ormonali e chirurgiche, ha potuto finalmente mostrarsi al mondo per quella che è sempre stata: una ragazza. Il mondo però non l'ha fatta sentire accolta e questo l'ha portata nei successivi due anni a chiudersi in se stessa e a uscire molto meno soprattutto da sola, situazione in cui si sentiva più vulnerabile. Durante il lockdown è stata costretta a rimanere a casa con i suoi genitori, che l'hanno sempre accettata e supportata durante il percorso e che hanno continuato a farlo anche durante la pandemia. Sonia, su loro suggerimento, ha iniziato a cercare online associazioni Lgbtqi+ che le potessero dare una mano e in questo modo ha conosciuto persone che come lei stavano affrontando lo stesso problema e con le quali è riuscita a sentirsi meno sola, grazie anche agli interventi dei professionisti che collaborano con queste associazioni. In questo modo si è resa conto di avere una rete sociale di supporto molto solida che l'ha aiutata a ripresentarsi in contesti sociali con una maggiore autostima, permettendo anche alle altre persone di vederla come si vedeva lei: una ragazza forte, piena di possibilità ma anche di debolezze, che non si è lasciata sopraffare dall'isolamento ma lo ha sfruttato per uscirne più sicura e consapevole.



Sentirsi meno soli

3.1 L'importanza di chiedere aiuto

Chiedere aiuto non è quasi mai semplice. Entrano in gioco componenti come l'orgoglio e la paura di essere giudicati o di arrecare disturbo che compromettono la nostra capacità di giudizio e ci portano a rimanere in silenzio e a vivere i nostri sentimenti nella nostra intimità e senza un supporto esterno. Ma cosa succederebbe se alla richiesta di aiuto associassimo un dono che facciamo agli altri piuttosto che un peso? Se la vedessimo come una possibilità di starci vicino invece che di una responsabilità? Proviamo a pensare semplicemente a quando siamo arrabbiati o nervosi per qualcosa e ce la prendiamo con qualcuno senza mai effettivamente spiegare cosa c'è che non va. L'altra persona si ritrova a essere un bersaglio colpito dalle nostre frecce senza però sapere da dove partono. Magari lo facciamo perché non riteniamo che i nostri problemi la interessino o perché temiamo di dare un'immagine fragile di noi ma il risultato, anziché essere quello di proteggerla dai nostri problemi, è quello di renderla vittima della nostra ira apparentemen-

te ingiustificata. Jhonny, un ragazzo che sta affrontando la transizione FtM, ci ha messo più di vent'anni prima di avere la forza di chiedere aiuto a una psicologa e più di due mesi prima di dire a sua madre quello che stava accadendo nella sua vita. Aveva paura, nel primo caso, di scoprire quello che già sapeva (ovvero che vestirsi da uomo non gli bastava e voleva che il suo cambiamento fosse più globale e che lo rispecchiasse nella sua interezza) e, nel secondo caso, temeva che i genitori lo avrebbero rifiutato e che avrebbero subito i giudizi della gente. Jhonny per la prima volta ha sperimentato la sensazione di leggerezza quando, presosi di coraggio, è andato da sua madre e le ha detto che aveva iniziato un percorso con una psicologa per poter iniziare la strada verso la transizione e, con sua insospettabile sorpresa, lei non ha battuto ciglio; si è seduta accanto a lui per parlare nel dettaglio di tutto quello che avrebbe dovuto affrontare. Jhonny in quel momento si è reso conto di aver passato molte notti insonni senza motivo a causa delle paure che lui stesso aveva alimentato per non aver dato fiducia alla capacità di accogliere della persona che aveva davanti. Sua madre, dopo anni di rapporti a metà col figlio che non riusciva ad aprirsi con lei, ha finalmente capito quale era il motivo e il suo comportamento si è allineato con i bisogni di Jhonny come mai prima di allora. Ma va sempre così bene? Chiedere aiuto agli altri è sempre utile? Anche qui non abbiamo una risposta univoca perché entrano in gioco altri fattori: la nostra capacità di scindere problemi reali da problemi futili, di mentalizzare i processi cognitivi ed emotivi dell'altro, di esporci senza maschere che possono falsare la nostra richiesta di aiuto.

Essere capaci di mettere da parte l'orgoglio è il primo passo da fare verso la strada della risoluzione del problema, e anche capire se è meglio parlarne con una persona a noi vicina

o con un professionista. Scardiniamo il tabù che andare dallo psicologo o chiedere aiuto siano segni di fragilità quando rappresentano, al contrario, il coraggio di chi non mette al primo posto il giudizio degli altri ma il proprio benessere. Molti dei miei pazienti arrivano in studio dicendomi: «Finalmente ho avuto il coraggio di chiamarla per prendere un appuntamento. Erano giorni/mesi/anni che rimandavo». In questa frase possiamo ritrovare alcuni degli elementi che ci rendono difficile chiedere aiuto: paura di chiamare un estraneo chiedendoci se sarà in grado di aiutarci, di apparire deboli e incapaci di risolvere i nostri problemi da soli, di doverlo poi dire a parenti e amici e di essere soggetti al loro giudizio. Quando si sceglie uno psicologo spesso si va alla cieca: si cerca su Internet, si guardano siti web o piattaforme di professionisti, senza sapere quanto siano reali o truffe, e si chiede consiglio a qualcuno che sappiamo esserci già stato o che conosce psicologi nel quartiere dove abitiamo. Ma questo è solo il primo passo. Okay, l'ho scelto e adesso? se non mi piace? se io non piaccio a lui? se non mi capisce o, peggio, mi capisce troppo bene? Queste sono solo alcune delle domande che ci facciamo se anche solo immaginiamo di voler chiamare uno psicologo.

Il secondo punto riguardava l'apparire deboli, ma cos'è che ci rende deboli o forti? fragili o coraggiosi? Molti secoli fa Publilio Siro diceva: «Quando si agisce cresce il coraggio, quando si rimanda cresce la paura». Avere il coraggio di affrontare le proprie paure aiuta a non farle crescere, a non fargli prendere il sopravvento su tutto il resto, come è successo a Jhonny che per settimane non ha dormito per paura della reazione di sua madre. Affrontare i propri problemi è il segno di maggior coraggio che potremmo mai dimostrare. Il fatto di renderci conto di non riuscire a superare le difficoltà da soli non fa di

noi delle persone fragili ma delle persone consapevoli del fatto che spesso il mondo ci mette di fronte a delle sfide che non si aspetta che affronteremo da soli, perché uno dei punti di forza della specie umana è stato creare una società (dal lat. *societas -atis*, deriv. di *socius*, «socio»). I nostri antenati si erano già resi conto che fare le cose da soli gli riusciva bene, ma farle con gli altri gli riusciva anche meglio. Ci saranno sempre persone che vedono la richiesta di aiuto come un segno di debolezza, come ci saranno sempre persone che credono che la Terra sia piatta.

L'ultimo elemento che ci crea difficoltà nel chiedere aiuto è la paura di parlarne con le persone a noi care. Per esempio, spesso è più facile dirlo a qualcuno appena conosciuto o che non sa niente di noi piuttosto che confessarlo alla nostra migliore amica o a nostro padre. Questo accade perché, da una parte, non vogliamo che si preoccupino eccessivamente, così tanto da doverne parlare con uno psicologo e, dall'altra, non vogliamo che pensino che siamo incapaci di farcela da soli. Al centro rimane sempre la paura del giudizio. Paura, paura, paura. Ma non è forse peggio avere in testa mille e più scenari apocalittici rispetto a ciò che potrebbero pensare, piuttosto che effettivamente sapere qual è il loro parere? Anche se fosse negativo non sarebbe solo uno rispetto a tutti i mille che ci creiamo nella nostra testa? Ci tengo però ad aggiungere che nulla dev'essere fatto contro voglia o perché convinti da qualcun altro. Arriva il momento in cui ci sentiamo pronti a chiedere aiuto o a confessare che abbiamo chiesto aiuto a qualcuno. Per Jhonny è stato così. Quando si è sentito pronto ha mandato una mail per parlare con una psicologa e dopo due mesi, quando di nuovo si è sentito pronto, ne ha parlato con sua madre. Non ci sono date di scadenza. Ognuno deve

rispettare i suoi tempi. A volte c'è bisogno di una spinta ma la scelta dev'essere comunque sempre nostra.

3.2 Aspetti positivi della monofobia

Cosa ci può essere di positivo nel soffrire di una fobia? Come abbiamo detto nel primo capitolo la paura è un'emozione primaria di difesa che ha permesso la sopravvivenza della specie, quel campanello di allarme che ci protegge e ci permette di rimanere in vita. Nel caso della monofobia i lati positivi riguardano il fatto che questa paura ci porta a fare i conti con noi stessi, a porci delle domande o a farcele porre dalla nostra persona sicura. La maggior parte delle persone non si chiede se potrebbe fare qualcosa per stare meglio e si trascina nella sua vita per abitudine, perché ha sempre fatto così, perché finora non c'è mai stato bisogno di cambiare, e magari è soddisfatto così e non sa che la vita è piena di altre sfumature oltre a quelle che conosce già.

Chi ha sperimentato la monofobia, invece, ha avuto modo di ascoltarsi più e più volte, e si è conosciuta meglio. Confrontarsi con se stessi e con gli altri ci aiuta a trovare la nostra strada, ad approfondire le nostre aspirazioni e a lottare per raggiungere i nostri obiettivi. Marta, oggi fiera leader del movimento femminista della sua città, grazie alla monofobia, ha capito che i suoi rimuginii e il suo costante interrogarsi su se stessa e sugli altri sarebbero potuti diventare il suo tratto distintivo e il suo punto di forza. È riuscita a sfruttare il suo bisogno di compagnia rendendolo terreno fertile per la condivisione di idee e la creazione di uno spazio sicuro per altre donne; ha trasformato la vecchia casa in

campagna dei suoi genitori in un centro di accoglienza per tutte quelle donne che per vari motivi ne avessero avuto bisogno rendendo la sua incapacità di stare da sola l'occasione di rinascita di qualcun altro.

Un'altra storia è quella di Michele che grazie alla sua persona sicura, suo cugino Carlo, ha scoperto che ciò che gli impediva di uscire senza di lui era l'insicurezza dettata proprio dalla sua presenza. Carlo, suo coetaneo, era da sempre stato un ragazzo sicuro di sé e amato da tutti i loro amici (e anche dalle ragazze che piacevano a Michele), e per questo quando erano insieme il cugino scompariva per vivere nella sua ombra. Un giorno però Carlo, consapevole delle difficoltà del cugino, gli suggerì di andare insieme a parlarne con uno psicologo e, già alla prima seduta, Michele confessò che stare in sua compagnia gli permetteva di non esporsi troppo e di conseguenza di non soffrire per eventuali rifiuti o altro. Michele, grazie all'intervento della sua persona sicura, ha continuato a fare gli incontri con lo psicologo e ancora oggi esce con suo cugino Carlo, ma solo quando ne hanno voglia e quando Michele non deve stare con la sua ragazza o ha voglia di stare da solo. In questo caso, l'aspetto positivo della monofobia si è manifestato attraverso la presenza di quell'unica persona sempre presente nella vita di Michele, che proprio grazie all'estrema vicinanza è riuscita a ipotizzare la possibile causa di un malessere che, una volta affrontato, gli ha migliorato la vita. Se Michele non avesse avuto bisogno di Carlo, probabilmente nessuno si sarebbe accorto che viveva una vita in sordina e lui si sarebbe accontentato di rimanere invisibile anziché diventare protagonista di una vita ricca di colori e sfumature.

3.3 Spiegare la monofobia agli altri

Fino qui abbiamo parlato dell'importanza di chiedere aiuto e degli aspetti positivi della monofobia, ma come fare per spiegare agli altri quello che proviamo quando spesso non lo sappiamo neanche noi? Quello verbale è uno dei canali più immediati che possediamo: la parola è la chiave per risolvere molti dei problemi che ci affliggono ma a volte non sappiamo come utilizzarla. Come facciamo a spiegare a parole l'universo di sensazioni che si scatenano dentro di noi quando rimaniamo da soli? Come è possibile che una persona che non abbia mai sofferto di attacchi di panico capisca quel senso di assoluta impotenza che ci pervade durante episodi simili? Iniziamo con l'avere fiducia in loro, in quelle persone che ci stanno accanto e che vorrebbero solamente capire quello che ci sta succedendo.

Gli esseri umani sono dotati (chi più, chi meno, chi purtroppo per nulla) di una capacità chiamata «empatia», che ci permette di metterci nei panni dell'altro e di intuire ciò che prova. Quando le persone a noi care vedono o sentono che c'è qualcosa che non ci fa stare bene provano a capire di cosa si tratti, ma se noi non gli forniamo delle linee guida da seguire rischiamo che loro non capiscano o fraintendano i nostri comportamenti e si allontanino da noi. Carlo è stato bravo a capire che Michele non stava bene ma non sapeva quale fosse la causa.

Prima di poter spiegare a qualcuno cos'è la monofobia sarebbe utile capirlo in prima persona, mettendoci in una posizione di ascolto e affrontando ciò che non va nella nostra vita. Una volta fatto il passo più difficile, ovvero accettare che c'è qualcosa che non va, il passo successivo è trovare il modo di farlo capire agli altri. Farlo capire agli altri non significa che dobbiamo mettere dei manifesti o fare

un post pubblico su Instagram per comunicarlo al mondo intero, significa condividere le nostre preoccupazioni con chi condividiamo la nostra vita, il nostro tempo, con quelle persone che tengono a noi e a cui noi teniamo.

Ma come trovare le parole giuste? Iniziamo con l'essere sinceri, non avendo paura di spaventare l'altro o di essere giudicati. Partiamo dall'idea che quelle persone vogliono davvero il nostro bene e per permettergli di starci vicino dobbiamo metterle in grado di capire quello che stiamo attraversando. Usare le metafore può essere d'aiuto, spiegare che quando rimaniamo da soli per noi è come rimanere da soli al buio in mezzo alla strada con le macchine che ci sfrecciano accanto e siamo incapaci di muoverci per non farci investire; o che quando la nostra persona sicura si allontana è come essere trattenuti sott'acqua senza riuscire a respirare né a tornare a galla.

Ovviamente, come abbiamo visto finora, ognuno presenta sintomi diversi e di varia entità ma per fortuna le metafore non mancano e possono essere un valido strumento di supporto alla nostra spiegazione. Un'altra possibilità può essere quella di chiedere aiuto al proprio psicologo, chiedergli di fare da mediatore e parlare alle persone con cui vogliamo condividere il nostro malessere. Ma a cosa serve spiegarla agli altri? In primo luogo a non sentirci soli. Essere soli è ciò che temiamo, sentirci soli è qualcosa che possiamo provare a risolvere. Quando condividiamo con qualcuno le nostre emozioni negative ci risulta più facile comprenderle e convivere perché in qualche modo condividiamo il peso di ciò che ci fa soffrire e sentendoci più leggeri diventa più semplice riuscire a capire cosa fare per stare meglio. Allo stesso modo quando proviamo emozioni positive se le condividiamo con qualcuno queste aumenteranno di intensità e le percepiremo con ancora più energia ed entusiasmo.

La parola «condividere» è formata da «con» (insieme) e «dividere» (separare) e significa unire qualcosa di diviso, mettere in comune. Quando si tratta di qualcosa che non ci fa star bene dividerla con qualcun altro (disposto a farlo con noi) ci permette di non portarne il carico da soli e di trovare le energie necessarie ad affrontarlo e risolverlo. Anche se può sembrare un atto di estremo egoismo l'idea di lasciare che un altro soffra come noi, condividere il peso non significa far soffrire anche l'altro. Essere empatici non significa provare le stesse emozioni che provano gli altri ma capire le loro emozioni, non viverle sulla nostra pelle. Allo stesso modo quando decidiamo di aiutare qualcuno con il suo fardello non ce lo prendiamo e viviamo come nostro, ma ci rendiamo contenitori temporanei, come una cassetta della posta pronta ad accogliere tutto ciò che dev'essere detto e condiviso, rispettando la nostra capienza e il nostro benessere. In conclusione, essere onesti e provare a trovare le parole giuste per spiegare ciò che proviamo, da soli o con l'aiuto di qualcuno, non farà stare meglio solo noi ma anche le persone che amiamo e che desiderano comprenderci per poterci stare vicino e se possibile darci una mano.





Nuove prospettive

La psicologia è in continua evoluzione e così anche i vari approcci che nascono dai costrutti del passato e si trasformano dando vita a prospettive nuove e stimolanti. Chi è andato più volte in terapia potrà confermare che è difficile trovare due professionisti uguali che utilizzano lo stesso metodo e nello stesso modo.

Il mondo è in continuo cambiamento, le persone cambiano con di conseguenza e la psicologia cerca di tenere il passo senza rimanere ancorata a strutture rigide e vincolanti. Molti approcci non credono sia importante dare la definizione specifica di un disturbo in quanto la manifestazione di esso non sarà mai la stessa in persone diverse; diventa quindi più importante prestare attenzione al sintomo, alla persona che abbiamo davanti, alle variabili di cui è costellata la sua vita e che tirano i fili del burattino che si rischia di impersonare.

4.1 *Psicologie non-strutturaliste*

Tra i nuovi approcci le psicologie non strutturaliste hanno l'obiettivo di omaggiare la psicologia tradizionale, svestendola delle sue caratteristiche statiche e strutturate e rendendola più flessibile e in continuo mutamento.

Per attuare questo cambiamento, Antonio Amatulli e Luigi Frezza, capostipiti di questa branca della psicologia in Italia, parlano di «de-costruzione», ovvero l'atto del mettere in discussione tutte quelle idee, da molti definite certezze o verità assolute, con l'obiettivo di andare oltre e di creare nuovi modi di vedere le cose e di interpretarle.

Grazie alla decostruzione possiamo mettere in discussione quello che diamo per certo e superarlo per migliorarci ed essere più onesti nei confronti di noi stessi.

Nel *setting* psicologico non strutturalista insegnare ai clienti la decostruzione significa permettergli di decostruire le loro credenze disfunzionali per costruire narrazioni rigenerative capaci di indirizzarli verso la strada verso il benessere, con l'obiettivo di guardare oltre e non rimanere ancorati al passato.

Uno degli obiettivi è proprio quello di non concentrarsi sui problemi del passato ma di focalizzarsi sulla costruzione di nuove soluzioni ai problemi, permettendo quindi al cliente (termine utilizzato dagli psicologi non strutturalisti al posto di paziente) di svincolarsi dal peso di ciò che non lo fa stare bene per concedersi la leggerezza della possibilità di scelta. Ma cosa sono nello specifico le psicologie non strutturaliste?

«Le psicologie ad approccio non strutturalista sono quell'insieme di metodi e tecniche di intervento psicologico che, tenendo conto dell'importanza di

decostruire le nostre certezze, per andare avanti, rendono la decostruzione centrale nella pratica della consulenza psicologica, clinica o aziendale».

Il primo atto di decostruzione è quello di sviluppare un setting dove non ci si sofferma sull'analisi dei problemi, ma «si favorisce nel cliente la costruzione di soluzioni, lo sviluppo di narrazioni potenzianti, tramite le quali lui arriva a imparare cosa vuol dire star bene secondo il suo soggettivo punto di vista e non si limita solamente a intervenire sulla rimozione del problema che lo ha portato in seduta». Si introducono in questo modo emozioni e sensazioni legate alla speranza e non solo al dolore fin lì vissuto.

In quest'ottica lo psicologo non è più il portatore della verità, di cosa sia giusto o sbagliato, ma diventa la persona che mette il primo mattone nella costruzione di una vita libera dal problema, utilizzando come metodi elettivi la Terapia Centrata Sulla Soluzione e la Terapia Narrativa.

Entrambi questi metodi mettono in risalto la relazione circolare tra psicologo e cliente, all'interno della quale spicca il punto di vista del paziente attraverso l'uso di specifiche domande, che mettono in risalto i suoi valori, le sue competenze e le sue convinzioni. In questo modo il cliente smette di essere considerato esclusivamente in base al suo problema e a ciò che fino a quel momento lo ha fatto soffrire e viene invece valorizzato e ascoltato per quello che desidera cambiare nella sua vita.

Il cambiamento diventa centrale, propulsore della ricerca del benessere non solo per il cliente ma per tutta la società, e se la psicologia non vuole rimanere indietro è fondamentale che si adegui ai mutamenti sociali. Già molti anni fa Zigmunt Bauman scrisse per la prima volta di società liquida, descrivendo la modernità come incerta e flessibile in

cui l'unica cosa permanente è il cambiamento¹¹. Nell'ottica di questa intuizione possiamo introdurre la definizione di «psicologia liquida», una psicologia fluida e alla portata di tutti e spendibile nella quotidianità. Le psicologie non strutturaliste cercano di inserirsi all'interno di questa società in continuo mutamento concentrandosi sulla creazione di un rapporto di fiducia tra psicologo e cliente, valorizzando il punto di vista di quest'ultimo e rendendolo protagonista della sua vita favorendo la costruzione di soluzioni.

Nei casi di monofobia l'approccio non strutturalista si concentra sulle possibili soluzioni che permetterebbero al cliente di superare il malessere anziché focalizzarsi esclusivamente sulla causa.

La Terapia Centrata sulla Soluzione si focalizza sul cercare di far uscire il cliente dal recinto del problema in cui si trova prigioniero andando a ricercare insieme le possibili soluzioni e le cose che riescono ancora a generare benessere. Per poterci riuscire è importante aiutare il cliente a recuperare le competenze utilizzate in passato, costruirne di nuove e riportare alla luce valori, motivazioni e speranze rimaste sopite. Ci si focalizza quindi sulle risorse e sulle infinite potenzialità di cui tutti noi disponiamo.

La Terapia Narrativa, invece, si focalizza sulla costruzione di senso, sul nostro modo di attribuire un significato a ciò che ci accade. La nostra vita è fatta di storie e se noi riuscissimo a decentrarci dalla nostra narrazione primaria disfunzionale, in favore di narrazioni potenzianti che mettano in luce i nostri punti di forza e le nostre speranze, saremmo in grado di influenzare il corso della nostra vita. Per far ciò il primo passo è quello di imparare a uti-

11 Cfr. A. Amatulli, *Terapia Solution Building Centrata sulle Competenze: Manuale di colloquio clinico (Psicologie Non Strutturaliste Vol. 1)*, 2019, p. 27.

lizzare un linguaggio esternalizzante, capace di separare la persona dal problema, non descrivendolo più come parte integrante di sé ma come qualcosa di esterno che si relaziona con noi ma che non ci definisce. Non andremo più a dire «Sono ansioso» ma «Spesso l'ansia interferisce con la mia vita», oppure «Mi capita di avere a che fare con l'ansia». In questo modo sarà più facile riuscire a vedere il problema come qualcosa di estrinseco e affrontabile e non come specchio di ciò che siamo.

4.2 *Mindfulness*

Un altro metodo sempre più utilizzato nel trattamento della sintomatologia ansiosa è quello legato alle tecniche di rilassamento, in special modo la Mindfulness (di cui abbiamo accennato nel capitolo 1).

Ma che cos'è questa Mindfulness di cui si parla tanto? Facciamo un passo indietro e addentriamoci all'interno della dottrina buddista dove è possibile distinguere diverse correnti di pensiero che descrivono la meditazione come un metodo alla portata di tutti capace di lenire le sofferenze umane.

La moderna meditazione Mindfulness si rifà alla pratica meditativa *theravada*, che contempla due tipi di meditazione: la *samatha* (concentrazione) e la *vipassana* (chiara visione) e consiste nel prestare attenzione intenzionalmente al momento presente in modo non giudicante. Il primo a sperimentare la Mindfulness in ambito clinico fu Jon Kabat-Zinn, un biologo statunitense che negli anni settanta elaborò il protocollo MBSR (Mindfulness-Based Stress Re-

duction) per la riduzione dello stress. Il punto focale di questo metodo è riuscire a diventare più consapevoli dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti e delle nostre sensazioni fisiche senza cadere vittime delle reazioni mentali automatiche che innescano giudizi e pensieri disfunzionali. L'obiettivo è quello di aprire la mente e metterci in una posizione di disponibilità all'ascolto vivendo appieno l'*hic et nunc*, il «qui e ora», lasciando fuori pensieri intrusivi per concentrarci sul momento presente.

Questo metodo si è rivelato efficace nella riduzione di sintomi fisici e psicologici legati allo stress e all'ansia e nella promozione di cambiamenti positivi rispetto alla percezione di sé e degli altri. All'interno del protocollo Mbsr vengono descritte quattro forme di meditazione: la *sitting meditation*, il *body scan*, l'*hatha yoga* e la *walking meditation*.

La *sitting meditation* è una meditazione che si pratica seduti prendendo consapevolezza del proprio respiro, del proprio corpo, delle proprie sensazioni, emozioni e dei propri pensieri, attraverso una postura rilassata e tenendo gli occhi chiusi o rivolti verso l'orizzonte; il *body-scan* consiste nel porre attenzione ai propri distretti corporei portando il respiro in ogni parte del corpo scansionata e può essere praticato da seduti, sdraiati o anche in piedi; l'*hatha yoga* è una pratica che facilita il mantenimento dell'attenzione attraverso il corpo e il suo movimento lento ma forte; infine la *walking meditation* è una meditazione camminata che produce un rilassamento progressivo grazie all'attenzione rivolta al movimento del proprio corpo in relazione al respiro. Per praticare in maniera efficace queste quattro forme di meditazione è importante non solo la capacità di restare ancorati al momento presente, ma anche la scelta del luogo in cui vengono praticate: se proviamo a fare la

sitting meditation in salotto su una sedia scomoda e con la televisione in sottofondo non riusciremo a raggiungere una condizione di rilassamento; così come provare a fare la walking meditation in mezzo al traffico rischia di peggiorare la condizione di ansia invece che affievolirla. Per padroneggiare queste forme di meditazione è opportuno rivolgersi a un professionista che una volta insegnata la tecnica ci renderà capaci di poterla praticare in autonomia dove e quando preferiamo.

Nel caso dei disturbi d'ansia possiamo vedere come essi siano caratterizzati da tre componenti in interazione tra loro: l'evitamento esperienziale, la riduzione del repertorio comportamentale e la relazione disfunzionale con le proprie esperienze interne. In merito a quest'ultimo aspetto, chi soffre di un disturbo d'ansia tende a reputare problematica non l'esperienza negativa che si presenta ma la sua reazione a essa, perpetuando in questo modo una serie di giudizi negativi verso se stesso. In questo modo si iniziano a evitare tutte quelle situazioni che potrebbero in qualche modo indurci ad avere paura; ma nonostante questo significhi una riduzione momentanea delle sensazioni spiacevoli, a lungo andare non ci permette di apprendere i modi funzionali di rispondere all'ansia e quindi di superarla. L'evitamento può essere di due tipi: finalizzato a ridurre temporaneamente il disagio (uso di sostanze stupefacenti, abbuffate, rituali di controllo), o rivolto all'eliminazione di comportamenti che però hanno un elevato valore personale e che quindi provocano una significativa riduzione della qualità della vita.

L'elemento centrale degli approcci basati sulla Mindfulness è la capacità di accettare le nostre esperienze interne, senza reagire in maniera rigida e giudicante, sviluppando un atteggiamento di compassione nei confronti delle nostre

emozioni. Se riusciamo a osservare i pensieri, le sensazioni e le emozioni non come specchio di ciò che siamo ma come eventi oggettivi della mente, transitori e naturali, saremo in grado di diminuire l'impulso a evitarli e a fuggire. Se riusciamo in questa impresa ci sarà possibile raggiungere la consapevolezza metacognitiva, chiamata anche decentramento, ovvero la capacità di vederci dal di fuori, di osservare i nostri pensieri senza identificarci con essi. Rispetto alle terapie comportamentali che hanno come obiettivo l'estinzione della risposta ansiosa mediante l'esposizione, gli approcci Mindfulness mirano a promuovere l'accettazione della risposta ansiosa per sviluppare la consapevolezza delle proprie esperienze interne. Attraverso il rilassamento non si cerca quindi di ridurre l'ansia ma di accettarla come qualcosa di transitorio che non ci rappresenta.

Chi soffre di monofobia spesso tenta la strada del rilassamento e della meditazione per provare a stare meglio ma in molti casi interrompe perché non riesce ad abbandonarsi completamente al momento presente senza giudicarsi o lasciarsi sopraffare dai pensieri. Per questo è fondamentale rivolgersi almeno inizialmente a un professionista che possa orientarci verso la forma di meditazione più efficace per noi. Se praticata consapevolmente la meditazione è capace di aumentare la felicità e ridurre i livelli di ansia, ruminazione e paura del fallimento. Il respiro diventa la nostra ancora per restare concentrati sul presente e ci permette di auto-osservarci per conoscerci meglio e riuscire ad ascoltarci nonostante la confusione assordante che spesso ci avvolge. Una persona che soffre di monofobia si trova così ad avere uno strumento potentissimo nelle sue mani che la rende capace di rispondere alla situazione di pericolo mettendo in atto un contrattacco ai suoi stessi pensieri. Chi ha paura di stare in casa da solo potrà iniziare con la

sitting meditation mentre chi fa fatica a uscire senza la sua persona sicura potrà provare con la walking meditation, scegliendo un luogo poco affollato e adatto per fare pratica. Ovviamente la pratica della meditazione non è efficace per tutti, per questo è importante che si conoscano le varie possibilità a nostra disposizione in modo da poter scegliere la strada più adatta a noi e al nostro percorso. Inoltre è fondamentale riuscire a non incolparsi se non si riesce a tener lontano i pensieri al primo tentativo, come in tutte le pratiche c'è bisogno di tempo, allenamento e pazienza per accettare che alcune volte non siamo efficaci al 100% e va bene così. Senza giudizio. Senza colpevolizzazioni. Solo ascolto, consapevolezza e respiro.





Riflessioni

5.1 Testimonianze

Ripercorriamo le storie che abbiamo incrociato in questa lettura e proviamo a metterci nei panni di chi le ha vissute: Come hanno affrontato la monofobia?

Per Elena, che ha iniziato a soffrire di monofobia a otto anni, dare un nome ai suoi problemi è stato un sollievo. Aveva bisogno di sapere che ciò che le stava accadendo aveva una definizione ed era risolvibile. Ha iniziato un percorso psicologico e ha imparato a mettere in prospettiva eventi della sua vita che risuonavano di significati che lei non aveva mai preso in considerazione. Prendere consapevolezza non è un percorso semplice, a volte ti fa sentire forte come un leone altre volte ti estirpa tutte le energie e ti lascia vuoto come la pelle di un serpente dopo la muta. Quando i miei pazienti attraversano dei momenti di sconforto io gli ricordo quanto sono stati coraggiosi a venire da me, a scegliere la strada più difficile, a decidere di affrontare il problema anziché nascondere insieme alla polvere sotto al tappeto. E nei loro occhi vedo brillare il ricordo

della difficoltà a iniziare il percorso e la forza nel decidere di affrontarlo, e subito sento ribollire in loro l'energia della sfida, della possibilità, della speranza di farcela di nuovo. Anche Giovanni ha iniziato un percorso psicologico durante la sua carriera da modello. Lui ha preferito una terapia centrata sulla soluzione che lo ha messo di fronte a scelte che non aveva mai avuto il coraggio di prendere e che lo avevano portato a comportarsi in modi che non lo facevano sentire a suo agio né con gli altri né con se stesso. Per la prima volta ha iniziato a dire di no e a riconoscere i veri amici dai follower opportunisti di cui aveva iniziato a circondarsi. Scegliere di chiedere aiuto non è sempre facile e neanche la scelta del professionista a cui affidarsi. È importante trovare qualcuno che sia in linea con i nostri valori e che sentiamo collaborativo ed empatico. Non esiste uno psicologo giusto per tutti, ognuno di noi ha le sue peculiarità e deve trovare il professionista adatto ad accoglierle.

La storia di Francesca è un po' diversa: i suoi amici, stanchi di vederla sempre e solo al fianco di Caterina, hanno deciso di parlarle e in questo modo hanno scoperto che la loro amica non aveva una ragazza eccessivamente invadente, al contrario; le hanno quindi consigliato di affrontare la situazione. In questo caso il supporto degli amici è stato fondamentale per Francesca che si è sentita accolta e non giudicata. Ha iniziato un percorso che si è poi trasformato in una terapia di coppia per aiutare anche Caterina ad affrontare questo nuovo viaggio insieme.

Greta, invece, a cinquantacinque anni si è resa conto che stava vivendo una vita non sua, fatta di scelte forzate e dettate dall'esterno. Si è guardata per la prima volta allo specchio e ha trovato una sconosciuta a fissarla con occhi spenti e senza energia. A volte servono proprio questi attimi di lucidità per farci capire che qualcosa non va nella

nostra vita e che se vogliamo riempirla di senso è necessario cominciare a navigare in acque sconosciute con o senza salvagente. Greta ha iniziato un corso di Mindfulness e lì ha conosciuto persone accoglienti che l'hanno compresa e le hanno dato la forza di affrontare passo dopo passo la paura di stare da sola.

Anche Daniele, dopo aver perso la moglie, si è fatto convincere dai figli a partecipare a un corso di Mindfulness che gli ha cambiato la vita. Non sempre ovviamente questi percorsi sono risolutivi e vanno bene per tutti, a volte ci vogliono più tentativi e altre volte sembra che non ci sia nulla che si possa fare per risolvere il problema, ma con la giusta motivazione e il supporto di persone fidate si possono scoprire sempre più modi per provare a stare meglio, bisogna solo trovare quello più giusto per noi.

Gabriele, per esempio, ha provato vari trattamenti per eliminare i suoi attacchi di panico per poi rendersi conto che l'ansia era solo la manifestazione di qualcos'altro che lui aveva cercato di nascondere a se stesso e agli altri: seguire la strada di famiglia (tutta laureata in legge) quando invece le sue passioni seguivano tutta un'altra direzione (musicale e teatro). La storia di Gabriele è più comune di quanto ci si possa aspettare, molte persone celano un'insoddisfazione latente che si manifesta attraverso attacchi d'ansia, problemi intestinali o mal di testa. Le somatizzazioni sono reazioni fisiologiche a malesseri che non riusciamo a esternare in altri modi e che il nostro corpo in qualche modo deve buttare fuori.

Ciò che mi preme sottolineare è che non esiste una soluzione che vada bene per tutti e che a volte il problema sta proprio nel voler trovare a tutti i costi una soluzione a qualcosa che semplicemente fa parte di noi. Se riusciamo nel compito di esternalizzare ciò che ci fa stare male ci ren-

diamo conto che avere un problema non significa essere il problema, ma contemplare la non perfezione, le sfumature, il fatto che non possiamo essere sempre felici e sorridenti e che alle volte dobbiamo solo accettare di avere delle debolezze che non ci rendono meno forti ma che sicuramente ci rendono più veri. Accettare significa però anche rendersi conto che nel momento in cui il problema causa eccessivo malessere in me o in chi mi sta accanto devo avere la forza di chiedere aiuto e trovare la strada migliore per stare meglio. Questo non significa necessariamente rivolgersi a uno psicologo ma, come nel caso di Isabella, aprire la mente a nuove prospettive e lasciare che le persone intorno a noi colorino di nuovo la nostra vita.

Ogni storia ha la sua strada, non sempre si imbocca subito quella giusta ma l'importante è continuare a rimanere in movimento.

5.2 Riflessioni conclusive

In questi anni che hanno seguito la comparsa del Covid-19 il mio lavoro è cambiato. Se prima parlavo con persone che non facevano che correre per trovare risposte, adesso ho di fronte persone che, volenti o nolenti, hanno dovuto fare i conti con loro stesse e sono state costrette a fermarsi e a prendersi il tempo di guardarsi. Guardarsi è un'attività che spesso diamo per scontata: ci vediamo sì, ma non sempre ci guardiamo. Quando ci mettiamo davanti a uno specchio vediamo il nostro volto riflesso, in modo rapido, immediato, così naturale da non porci attenzione. Durante il lockdown siamo stati costretti a guardarci di più però, a osservarci

senza filtri e senza fretta e questo lo vedo in Marco, che è venuto da me perché ha capito che stava correndo troppo e aveva perso di vista quello che per lui contava davvero; lo vedo in Sonia, che ha sviluppato un'intolleranza cronica nei confronti della sua famiglia perché ha scoperto che la sua mente va più veloce e non sempre in parallelo alla loro; lo vedo in Fabio, che era venuto da me subito dopo il periodo di chiusura totale ma che poi ha abbandonato perché risucchiato nuovamente delle frenetiche abitudini a cui era abituato. Alla luce di tutto ciò che è stato distrutto da questo virus, io vorrei provare a soffermarmi su ciò che di buono invece ci ha portato. Una volta, durante un incontro online con il Gruppo Donne dell'Arcigay di Catania, una delle partecipanti mi ha detto: «Io non vedo il bicchiere né mezzo pieno né mezzo vuoto, io vedo il bicchiere brillante». Ho ripensato molte volte a questa frase e ho creato nella mia mente l'immagine del mio bicchiere brillante riempendolo con tutto ciò che mi ha mai regalato un sorriso. Io lavoro spesso con le carte da gioco Dixit, e uno dei modi in cui le utilizzo è quello di selezionarne alcune e chiedere di sceglierne una che rappresenti le fatiche vissute durante il lockdown e una che rispecchi invece le risorse che non si sapeva di possedere o che sono state messe in atto. Lo scopo di questa attività è quello di aprire una nuova finestra visiva che permetta anche alle cose positive di entrare in scena, come il raggio di sole che illumina ciò che fino a un momento prima sembrava solo scuro e ostile. Quando ci capita qualcosa di brutto tendiamo a concentrarci solo sull'evento negativo in sé, non ci interroghiamo sui possibili risvolti positivi che questo potrebbe portare. Allo stesso modo, chi soffre di monofobia, può provare a domandarsi se quello che gli capita non porta in sé anche qualcosa di positivo, una piccola sfumatura di possibilità anziché solo

un muro di arresto. Quando incontro una persona che viene in studio da me per la prima volta gli chiedo sempre cosa si aspetta dai nostri incontri, quale obiettivo vorrebbe raggiungere e quali sono i valori importanti che persegue nella sua vita. Con queste prime domande iniziamo a conoscerci e possiamo decidere insieme in che modo impostare il percorso secondo i desideri e i bisogni emersi durante quel primo incontro. L'individualità di ognuno è *conditio sine qua non* per creare una solida base relazionale; quello che dobbiamo sempre ricordarci è che siamo tutti unici e nella nostra unicità ognuno di noi ha necessità uniche che meritano di essere ascoltate. Ma questo non è utile solo per noi psicologi: se nella quotidianità ci ascoltassimo di più senza lasciarci distrarre da tutto il resto, le nostre relazioni sarebbero più piene e soddisfacenti, più consapevoli. La consapevolezza è uno dei regali che le quarantene forzate hanno donato. Avere più tempo a contatto con noi stessi ci ha inevitabilmente portati a interrogarci e ad ascoltarci, e quando non abbiamo voluto farlo indirettamente lo abbiamo fatto lo stesso, perché non volersi ascoltare significa che sappiamo che c'è qualcosa che non sta andando come vorremmo, o che non stiamo facendo come dovremmo. La consapevolezza può essere allo stesso tempo nostra amica e nemica, ma se ci concediamo il diritto di accoglierla vedremo che è dotata di una forza inarrestabile capace di condurci proprio dove vogliamo arrivare.

